

TALLA ALTA

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

- Estatura más de 2 DS para la media correspondiente a edad cronológica y sexo, o bien a la existencia de una velocidad de crecimiento excesiva (>P75)
- La talla de un individuo está determinada por la interacción entre múltiples causas o genes

Clasificación etiológica

Variantes de la normalidad

- Talla alta familiar
- Maduración acelerada familiar

Obesidad

Causas hormonales

- Gigantismo hipofisiario o Acromegalia
 - Síndrome Mc Cune Albright
 - Adenomas eosinófilos o cromófilos
 - Secreción aislada de GH o mixta (GH + Prolactina)
 - Plurihormonal (TSH, Subunidad alfa, prolactina)
 - Adenomas ectópicos
 - Adenomatosis múltiple endocrina
 - Túmulos secretores de GHRH
- Hiperinsulinismo (DBT lipoatrófica)
- Hipertiroidismo
- Hipersecreción de hormonas sexuales (pubertad precoz)
- Déficit o insensibilidad a esteroides sexuales
 - Hipogonadismo primario (ovárico o testicular)
 - Hipogonadismo hipogonadotrófico (Kallmann)
 - Resistencia a estrógenos
 - Déficit de aromatasa
 - Resistencia a andrógenos (feminización testicular)
 - Deficiencia de 17β hidroxilasa
- Deficiencia glucocorticoidea familiar

Talla alta sindrómica

- Trastornos cromosómicos
 - Síndrome Klinefelter XXY
 - Síndrome XYY, XXYY
 - Síndrome X frágil
 - Trisomía 8, mosaicismo
- Otros Síndromes genéticos
 - **Síndrome Marfan**
 - Neurofibromatosis tipo I
 - Síndrome Tebbi
 - Síndrome Partington

Hipercrecimiento prenatal

- Síndrome Beckwith-Wiedemann
- Síndrome Sotos
- Síndrome Weaver
- Síndrome Simpson-Golabi-Behmel
- Síndrome Nevo
- Síndrome Elejalde
- Síndrome Perlman
- Síndrome Bannayan-Riley-Ruvalcaba

Variantes normales

Talla alta familiar

- Variante normal de patrón de crecimiento
- Talla elevada armónica por encima de la media de la población normal y ausencia de rasgos patológicos
- Antecedentes familiares de talla alta
- Velocidad de crecimiento normal
- Canal de crecimiento por encima de +2 DS para edad y sexo
- La edad ósea se corresponde con la edad cronológica
- La pubertad se inicia a una edad normal
- La talla final es alta, pero adecuada a la talla familiar

Maduración acelerada familiar

- Suelen alcanzar la talla final antes que el resto de los niños de su edad
- Antecedentes familiares de maduración acelerada
- Aceleración idiopática de la velocidad de crecimiento y edad cronológica
- Canal de crecimiento dentro de límites normales
- La pubertad se inicia precozmente
- La exploración física es normal
- La talla final es normal o baja

Hipercrecimiento patológico

TALLA ALTA PROPORCIONADA

Síndromes dismórficos

1. SINDROME WEAVER

- Cuadro de aparición esporádica caracterizado por crecimiento excesivo prenatal (macrosomía) que persiste a lo largo de toda la niñez dando lugar a una talla adulta elevada
- Se asocia a múltiples alteraciones craneofaciales, hipertoniá, alteraciones del esqueleto en pies y manos y cierto retraso psicomotor (caminan y hablan más tarde)
- Facies típica: micrognatia, occipucio plano, hipertelorismo, frente prominente, epicantus con depresión de la raíz nasal
- Maduración ósea acelerada (dedos prominentes, uñas pequeñas)

2. SINDROME BECKWITH-WIEDEMAN

- Duplicación genética a nivel 11 p13
- Cuadro de comienzo prenatal que se caracteriza por macrosomía fetal, alteraciones faciales con macroglosia, visceromegalia y onfalocoele
- Cursa con hiperglucemias neonatales graves, debido a hiperinsulinismo por hiperplasia de los islotes pancreáticos. Suele ir desapareciendo a lo largo de la infancia para luego desarrollar tendencia a intolerancia a HC y DBT
- Crecimiento acelerado y edad ósea cerca del P90 durante toda la infancia
- Pueden presentar retardo intelectual
- Mayor tendencia a desarrollar tumores (tu willms, hepatoblastomas)
- Concentraciones de IGF-I y II normales

3. SINDROME BERARDINELLI

- AR
- Lipodistrofia generalizada con ausencia de tejido graso subcutáneo e hipertrofia muscular, gigantismo moderado con rasgos acromegaloideos y genitales externos grandes
- Más frecuente en varones
- Se asocia a déficit psiquiátrico
- Hiperlipidemia e hiperglucemia no cetósica con resistencia insulínica y acantosis nigricans

4. SINDROME SIMPSON-GOLABI-BEHMEL

- Ligado al X
- Exceso de crecimiento prenatal y postnatal que continua hasta la pubertad aunque la talla adulta no suele ser tan extrema
- Fenotipo típico: macrosomía, talla >P97 y facies típica (puente nasal ensanchado, boca abierta con labio gruesos, depresión en la línea media del labio inferior, macroglosia, paladar hendido y mandíbula prominente)
- Se asocia a otros rasgos dismórficos: pectum excavatum, escoliosis, hepatoesplenomegalia, hernia inguinal o umbilical, cuello, manos y pies cortos y anchos con polidactilia

Cromosomopatías

SINDROME KLINEFELTER

- Exceso de uno o más cromosomas X en el varón (47XXY)
- Incidencia 1/1000
- Son niños altos delgados, con hábito eunucoide, con miembros inferiores altos, testículos pequeños hipoplásicos, ginecomastia y esterilidad
- Es frecuente la criptorquidia, hipospadias, pene corto y sinostosis radiocubital
- Retraso mental o trastornos del comportamiento

VARONES XYY

- Incidencia 1/1000
- Talla alta elevada durante la infancia alcanzándose una altura media de 189 cm con rasgos eunucoideos
- Típico la aparición de acné nódulo-quístico durante la pubertad
- Comportamiento antisocial
- Retraso intelectual

Gigantismo hipofisario

- Rara
- Producida por exceso GH antes de que se produzca el cierre epifisario
- Causa más frecuente: adenoma eosinófilo hipofisario secretor de GH
- Aumento en la velocidad de crecimiento que inicia en la pubertad y prosigue hasta la 3ª década de vida (talla final 225cm +3-4 DS por encima de P50)
- Rasgos acromegálicos: aumento PC, agrandamiento de la nariz, lengua y mandíbula (separan los dientes), rasgos faciales toscos y crecimiento desproporcionado de manos y pies
- Es frecuente la hiperprolactinemia y la intolerancia a la glucosa
- Niveles muy aumentados de GH y falta de supresión con la sobrecarga oral de glucosa son diagnósticos
- Tratamiento: Qx de elección. Si esta no es posible: bromocriptina (agonista dopaminérgico) + octreotido (análogo de la somatostatina)

HIPERTIROIDISMO Y PUBERTAD PRECOZ

- Acción más intensa sobre la maduración ósea que sobre el crecimiento longitudinal (periodo de crecimiento se acorta)
- Talla final normal

HIPERINSULINISMO

- Causa del hipercrecimiento prenatal de los hijos de madre diabética.
- Cesa tras el nacimiento y no da lugar a diagnóstico diferencial fuera del periodo neonatal

TALLA ALTA DESPROPORCIONADA

Displasia epifisaria hemimelica

- Es la única displasia ósea que cursa con hipercrecimiento
- Se asocia a gigantismo parcial (generalmente de uno de sus miembros inferiores)
- Es frecuente la fragmentación de las epífisis distales de fémur y tibia

Síndromes con aracnodactilia

- Son un conjunto de enfermedades hereditarias del tejido conectivo
- Comparten el fenotipo marfanoide: talla alta, habito asténico, facies alargada, extremidades largas y aracnodactilia
- Índice metacarpiano: cociente de la longitud media de los metacarpianos 2º a 5º y la media de su anchura. Normal: 7,9 Aracnodactilia: 8,5

Síndrome de Marfan

- Es una enfermedad congénita AD
- Al nacer los niños ya son largos y delgados y así se mantienen durante toda la niñez y en la edad adulta
- Predominio porción inferior del cuerpo (miembros largos y finos)
- Hipotonía y laxitud ligamentaria y a lo largo de los años se van manifestando otras malformaciones: escoliosis, pectum excavatum o carinatum, escleróticas azules, subluxación del cristalino, miopía grave, prolapso mitral, dilatación de la raíz aortica
- Desarrollo intelectual normal
- Aracnodactilia con contracturas en flexión